Machine Translated by Google

r evueneurologique 1 6 8 (2 0 1 2) 5 9 8 – 6 0 4

Disponible en línea en
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

Los ganglios basales y el sistema límbico: una nueva frontera

Apatía y enfermedad de Parkinson: aspectos clínicos, fisiopatología y evaluación

Apatía en la enfermedad de Parkinson: características clínicas, mecanismos y evaluación

K. Dujardin a, *, L. Defebvre [a]

[a] Departamento de Neurología y Trastornos del Movimiento, Hospital Salengro, Hospital Universitario, rue Emile-Laine, 59037 Lille Cedex, Francia

artículo informativo

Historial del artículo:
Recibido el 6 de abril de 2012
Recibido en forma revisada el 7 de mayo de 2012
Aceptado el 10 de mayo de 2012
Disponible en línea el 24 de agosto de 2012

Palabras clave:
Apatía
Motivación
Ganglios linfáticos basales
Demence
Depresión

Palabras clave:
Apatía
Motivación
ganglios basales
Demencia
Depresión

reanudar

La apatía corresponde a una disminución de la motivación en comparación con el estado previo del individuo. Afecta el comportamiento, la cognición y el estado emocional. Constituye una de las principales manifestaciones conductuales de la enfermedad de Parkinson. Si bien puede ser un síntoma de un estado depresivo, a menudo se presenta como un síndrome aislado en pacientes con Parkinson. Tiene poca relación con la gravedad de los trastornos motores, pero se asocia frecuentemente con la gravedad de los trastornos cognitivos. Constituye un factor predisponente para la demencia en la enfermedad de Parkinson. La apatía también es una posible complicación del tratamiento que implica la estimulación de los núcleos subtalámicos. La detección y evaluación de la apatía requiere el uso de herramientas específicas, algunas de las cuales están validadas en la enfermedad de Parkinson. Desde una perspectiva fisiopatológica, la apatía resulta de una disfunción del circuito límbico que conecta el estriado ventral con la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. Si bien la denervación dopaminérgica de estas regiones parece estar particularmente involucrada, es probable que otros mecanismos también estén involucrados. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en el tratamiento terapéutico de este trastorno debilitante.

2012 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

abstracto

La apatía es una pérdida de motivación en comparación con el nivel previo de funcionamiento del sujeto. Afecta el comportamiento, la cognición y el estado emocional del sujeto. Es una de las principales manifestaciones conductuales de la enfermedad de Parkinson. Aunque puede ser un síntoma de depresión, a menudo se presenta como un síndrome aislado en pacientes con Parkinson. La apatía no suele estar relacionada con la gravedad de los síntomas motores, sino que frecuentemente se asocia con la gravedad del deterioro cognitivo. La apatía también es una posible complicación del tratamiento mediante estimulación del núcleo subtalámico. El cribado y la evaluación de la apatía requieren el uso de herramientas específicas, algunas de las cuales están validadas en la enfermedad de Parkinson. Desde un punto de vista fisiopatológico, la apatía resulta de una disfunción del circuito límbico que conecta el estriado ventral con la corteza orbitofrontal y cingulada anterior. La denervación dopaminérgica en estas regiones parece desempeñar un papel clave, pero probablemente intervengan otros mecanismos. Se requieren más estudios para avanzar en el manejo terapéutico de este síndrome invalidante.

2012 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

* Autor correspondiente.
Dirección de correo electrónico: kathy.dujardin@univ-lille2.fr (K. Dujardin).
0035-3787/$ – véase la portada n.° 2012 Elsevier Masson SAS. Reservados todos los derechos.
doi:10.1016/j.neurol.2012.05.002

Machine Translated by Google

La enfermedad de Parkinson, la principal enfermedad degenerativa que afecta a los ganglios basales, se caracteriza por sus trastornos motores característicos, pero también se acompaña de alteraciones cognitivas y psicoafectivos. Estas últimas, en ocasiones, se presentan desde las primeras etapas de la enfermedad.

Los más frecuentes son la depresión, la ansiedad, las alucinaciones visuales, las conductas adictivas, pero también la apatía.

1. Apatía: definición y criterios diagnósticos

Este trastorno motivacional se caracteriza esencialmente por una reducción de los intereses, una menor participación en las actividades habituales, falta de iniciativa, tendencia al abandono prematuro de actividades iniciadas, indiferencia hacia uno mismo y hacia los demás, y embotamiento emocional. Como demostró Marin (1991), no es simplemente un síntoma de un estado depresivo o demencial, sino que la apatía existe como un síndrome en sí misma. En su definición, Marin enfatiza el componente motivacional y considera la apatía como una falta de motivación. Otros autores enfatizan la espontaneidad y definen la apatía como una disminución de la capacidad de respuesta a estímulos externos o internos, manifestada por una reducción de las actividades voluntarias (Stuss et al., 2000). Levy y Dubois (2006) propusieron una definición operativa de la apatía, que consideran como la reducción (en comparación con el estado habitual del sujeto) de las conductas voluntarias y dirigidas a un objetivo. Esta diversidad

Tanto los problemas conceptuales como la superposición entre las manifestaciones clínicas de la apatía y las de otros trastornos como la depresión, la anhedonia, el deterioro cognitivo o incluso ciertos rasgos de personalidad han retrasado el consenso en torno a los criterios diagnósticos de la apatía.

Tras una conferencia de consenso organizada por la Asociación Europea de Psiquiatría Biológica, se propusieron criterios de diagnóstico clínico (Robert et al., 2009) y se validaron en diversas patologías psiquiátricas y neurológicas (Mulin et al., 2011), incluida la enfermedad de Parkinson (Drijgers et al., 2010). Según estos criterios, presentados en la Tabla 1, la apatía corresponde a una disminución de la motivación en comparación con el estado previo del paciente, referida por el paciente o su familia, y presente de forma persistente durante al menos cuatro semanas. Afecta la conducta, con pérdida de iniciativa; la cognición, con reducción de áreas de interés; y la emoción, con embotamiento emocional. Desde un punto de vista operativo, esta disminución de la motivación se manifiesta a través de síntomas que afectan al menos a dos de estas tres áreas.

El impacto en el nivel de funcionamiento del sujeto es significativo y no puede explicarse únicamente por la discapacidad sensorial o motora del paciente.

2. Apatía y enfermedad de Parkinson

La prevalencia de apatía en la enfermedad de Parkinson varía entre el 17 % y el 70 % según el estudio (Aarsland et al., 2009). Esta variabilidad está relacionada con la diversidad de las muestras estudiadas.

Tabla 1 – Criterios diagnósticos de apatía.

El diagnóstico de apatía requiere cumplir los criterios A, B, C y D.

A. Pérdida o disminución de la motivación respecto a la condición previa o al funcionamiento normal para la edad y nivel cultural del paciente.
Este cambio lo refiere el propio paciente o su familia.

B. Presencia persistente, durante al menos 4 semanas, de al menos un síntoma en al menos dos de las tres áreas siguientes
B1. Comportamiento
Pérdida o reducción de conductas voluntarias, evidenciada por al menos uno de los siguientes síntomas
Pérdida de conductas autoiniciadas (p. ej., iniciar una conversación, realizar actividades de la vida diaria, iniciar una actividad social, comunicar opciones)
Pérdida de conductas en respuesta a estímulos ambientales (por ejemplo, responder en una conversación, participar en una actividad social)

B2. Cognición.
Pérdida o reducción de las actividades cognitivas dirigidas a un objetivo, evidenciada por al menos uno de los siguientes síntomas: Pérdida de espontaneidad o curiosidad sobre eventos nuevos o habituales (p. ej., iniciar tareas complejas, mostrar interés en eventos recientes, responder a oportunidades sociales, demostrar interés en asuntos personales, familiares o sociales).

Pérdida de capacidad de respuesta a comentarios o preguntas de quienes los rodean sobre eventos nuevos o habituales (por ejemplo, sobre la residencia, el vecindario o el distrito)
B3. Emoción:
Pérdida o reducción de las emociones evidenciada por al menos uno de los siguientes síntomas
Ausencia de sensibilidad emocional (p. ej., sensación subjetiva de falta o ausencia de emoción, u observación por parte de otros de un afecto atenuado), referida por el propio sujeto u observada por otros. Pérdida de reactividad
emocional ante eventos positivos o negativos del entorno (p. ej., quienes lo rodean informan de ausencia o baja reactividad emocional ante eventos agradables, una experiencia personal difícil, una enfermedad grave o noticias perturbadoras).

C. Los criterios (A y B) causan sufrimiento y/o interfieren en la vida social y ocupacional.

D. Los criterios (A y B) no están relacionados con una reducción del nivel de conciencia ni con los efectos directos de una sustancia; no se explican exclusivamente por una discapacidad física (p. ej., ceguera, sordera, etc.) o trastornos motores.

De apre`s Robert et al., 2009.

Machine Translated by Google

(población general, servicios especializados, pacientes institucionales...) y métodos de evaluación (impresión clínica, escalas específicas o no específicas).

En pacientes con Parkinson, la gravedad de la apatía generalmente no está relacionada con la gravedad de las deficiencias motoras, aunque un estudio encontró dicha correlación en pacientes recién diagnosticados (Pedersen et al., 2010). La apatía parece estar relacionada con la gravedad de las deficiencias cognitivas, en particular la disfunción ejecutiva. Pluck y Brown (2002) evaluaron la apatía en 47 pacientes con Parkinson sin demencia. Los pacientes con un alto nivel de apatía no estaban más deprimidos o ansiosos y no exhibieron rasgos de personalidad diferentes en comparación con aquellos con un bajo nivel de apatía. Sin embargo, a pesar de la eficiencia cognitiva generalmente preservada, presentaron síntomas disejecutivos más graves. Czernecki et al. (2002) describieron resultados comparables. En una muestra más grande de 159 pacientes con Parkinson, observamos una correlación negativa entre la puntuación obtenida en la Escala de Demencia de Mattis y la gravedad del síndrome apático (Dujardin et al., 2007). Además, el porcentaje de demencia entre los pacientes con apatía severa fue del 52%, en comparación con el 15,7% en los pacientes sin apatía. Recientemente, realizamos un estudio longitudinal con un grupo de 40 pacientes con Parkinson: 20 apáticos y 20 sin apatía. Al inicio, ninguno presentaba demencia ni depresión, y todos recibían tratamiento antiparkinsoniano óptimo. Tras 18 meses de seguimiento, el deterioro de las funciones cognitivas, en particular de las funciones ejecutivas, fue significativamente más pronunciado en los pacientes apáticos que en los pacientes sin apatía.

El 40% de los pacientes apáticos desarrolló demencia, en comparación con el 0,5% de los pacientes no apáticos (Dujardin et al., 2009). Este resultado sugiere que la apatía podría ser un factor de riesgo para la progresión a demencia en pacientes con Parkinson, como se ha demostrado en casos de deterioro cognitivo leve (Robert et al., 2006). Otro estudio longitudinal realizado durante cuatro años con pacientes con Parkinson en la población general muestra que el deterioro cognitivo y la gravedad de los signos axiales son los principales factores de riesgo para el desarrollo de apatía (Pedersen et al., 2009a,b). Estos datos refuerzan la idea de una fisiopatología común para los trastornos de la cognición y la motivación.

También existen vínculos entre la apatía y la depresión en la enfermedad de Parkinson. De hecho, los síntomas depresivos son frecuentes, con un promedio de 17% de depresión mayor, 22% de depresión menor y 13% de distimia entre los pacientes de Parkinson (Reijnders et al., 2008). Siendo la apatía uno de los síntomas de la depresión, una proporción significativa de pacientes apáticos se encuentran entre aquellos con enfermedad de Parkinson que están deprimidos: 86% en el estudio de Kirsch-Darrow et al. (2006), y 54% en el de Drijgers et al. (2010). Sin embargo, a pesar de su comorbilidad relativamente frecuente, la apatía existe como un síndrome distinto en la enfermedad de Parkinson, como lo demuestran varios estudios (Levy et al., 1998; Starkstein et al., 1992; Sockeel et al., 2006; Kirsch-Darrow et al., 2006). Por lo tanto, Kirsch-Darrow et al. (2006) muestran que los pacientes con Parkinson presentan con mayor frecuencia apatía aislada (28,8% de la muestra examinada) que apatía asociada a depresión (22,5% de la muestra examinada). Sin embargo, en este estudio, la presencia de una

El diagnóstico de apatía o depresión se basó simplemente en las puntuaciones obtenidas en las escalas de apatía y depresión, respectivamente. Utilizando criterios diagnósticos válidos, Drijgers et al. (2010) encontraron resultados convergentes a pesar de las prevalencias más bajas: el 17,2% de los 122 pacientes con Parkinson sin demencia examinados eran apáticos; entre ellos, el 67% tenía apatía aislada y el 33% tenía apatía asociada a un episodio depresivo mayor. La similitud semiológica entre la apatía y la depresión probablemente esté relacionada con bases fisiopatológicas parcialmente compartidas, que involucran particularmente al sistema límbico. Sin embargo, la confusión también proviene del hecho de que la mayoría de las escalas de depresión contienen ítems que abordan síntomas comunes a ambos síndromes y consideran la apatía como una simple manifestación de la depresión, lo que lleva a una sobreestimación de los estados depresivos. Si bien algunos síntomas (pérdida de interés, falta de iniciativa, aislamiento social) son comunes a ambas afecciones, también existen claras diferencias entre la apatía y la depresión. Los síntomas disfóricos (tristeza, culpa, sentimientos de inutilidad, desesperanza, pensamientos suicidas) caracterizan al individuo deprimido, mientras que el individuo apático muestra poca o ninguna respuesta emocional.

La pérdida de interés en la depresión suele estar asociada a sentimientos de desesperanza y pesimismo, lo que no ocurre en la apatía, donde se da menos importancia a áreas como la socialización, la productividad, la iniciativa o la perseverancia. La autocrítica y los pensamientos negativos sobre el futuro son comunes en la depresión, mientras que están ausentes en la apatía, que tiende a caracterizarse por la indiferencia. En este contexto, es muy probable que la prevalencia de la apatía se subestime en pacientes con Parkinson, lo que justifica una evaluación rigurosa y el uso de criterios validados para disociar la depresión de la apatía (Marsh et al., 2006; Robert et al., 2009).

La apatía es una posible complicación de la estimulación del núcleo subtalámico (STN). Este tratamiento quirúrgico se reserva actualmente para pacientes con párkinson cuyos síntomas motores son graves, fluctuantes y no se controlan adecuadamente con medicación. Su eficacia en los síntomas motores, en particular los segmentarios, está bien demostrada, pero el procedimiento puede conllevar efectos adversos (Voon et al., 2006), incluida la apatía. Este tema se aborda específicamente en otro artículo de este número.

3. Fisiopatología

Los principales síntomas de la enfermedad de Parkinson se deben a la depleción dopaminérgica estriatal. Esta depleción es inducida por la muerte de neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra e interrumpe el funcionamiento de las asas estriado-tálamo-corticales. Estas asas parecen estar implicadas en la mayoría de las situaciones patológicas que causan apatía, en particular el circuito límbico que conecta las regiones ventrales del cuerpo estriado con la corteza cingulada anterior y la región orbitofrontal. Ya en 1993, Cummings informó de la existencia de un síndrome cingulado.

Machine Translated by Google

anterior caracterizada por apatía, falta de iniciativa y una reducción de las manifestaciones emocionales, en caso de lesión de esta región frontal, pero también tras una disfunción del estriado ventral (núcleo accumbens)

(Cummings, 1993). Esta participación del circuito límbico en las conductas motivadas se ha confirmado en varias ocasiones. En sujetos sanos, en un estudio de imágenes de activación funcional, Pessiglione et al. (2007) demostraron que la motivación para alcanzar una meta (en este caso, el esfuerzo para ganar una suma virtual) provoca la activación bilateral del cuerpo estriado y el pálido ventral. Migneco et al. (2001) compararon la medición del flujo sanguíneo cerebral mediante tomografía monofotónica en pacientes con y sin demencia, apáticos y no apáticos, y observaron hipoperfusión cingulada en el grupo apático. En un estudio de correlaciones clínico-metabólicas en pacientes con lesiones del lóbulo frontal, Sarazin et al. (2003) observaron que la gravedad de la apatía se correlaciona con la reducción del metabolismo de la glucosa en la región frontomedial derecha.

Varios estudios han investigado los mecanismos fisiopatológicos de la apatía en pacientes con Parkinson. Reijnders et al. (2010) utilizaron morfometría basada en vóxeles para identificar los correlatos anatómicos de la apatía en un grupo de 60 pacientes con Parkinson, el 16% de los cuales eran apáticos. La gravedad de las manifestaciones apáticas se correlacionó significativamente con una reducción en el volumen de materia gris en el giro precentral, el giro parietal inferior, la ínsula, el giro frontal inferior y el giro cingulado posterior bilateralmente, así como en el precúneo derecho. Por lo tanto, se identificaron regiones involucradas en el circuito límbico, pero también regiones involucradas en la iniciación motora (giro precentral), la orientación atencional (giro parietal inferior) y la autoconciencia y la experiencia emocional (ínsula, giro cingulado posterior, precúneo). La mayoría de los demás estudios han utilizado imágenes funcionales. En pacientes con Parkinson deprimido, Remy et al. (2005) demostraron que la gravedad de la apatía se correlacionaba inversamente con la captación de [¹¹C]RTI-32, un marcador de los transportadores de membrana de dopamina y noradrenalina, en el cuerpo estriado ventral, lo que sugiere una implicación de la denervación catecolaminérgica estriatal en la apatía. Varios estudios han utilizado el modelo de estimulación del STN para explorar la fisiopatología de la apatía en la enfermedad de Parkinson.

En 12 pacientes evaluados tres meses antes y tres meses después del inicio del tratamiento con estimulación del núcleo subtalámico (STN), Le Jeune et al. (2009) observaron mediante tomografía por emisión de positrones con 18FDG que el empeoramiento de la puntuación de apatía se correlacionaba con un aumento del metabolismo de la glucosa en las circunvoluciones frontales media e inferior derechas, así como con una reducción del metabolismo de la glucosa en la circunvolución cingulada bilateralmente y en la circunvolución frontal medial derecha. Según estos autores, la estimulación del STN, si bien es eficaz en el dominio motor, podría alterar el funcionamiento del dominio límbico de esta estructura y, en consecuencia, desestabilizar el circuito límbico.

En un estudio de tomografía por emisión de positrones con [11C]racloprid, un ligando del receptor de dopamina D2/D3, Thobois et al. (2010) compararon la denervación dopaminérgica mesolímbica en pacientes con Parkinson tratados con estimulación del núcleo subtalámico (STN), tanto apáticos como no apáticos. Observaron que el índice de unión de [11C]racloprida fue significativamente mayor en pacientes apáticos en comparación con pacientes no apáticos en la corteza orbitofrontal, prefrontal dorsolateral y cingulada posterior bilateralmente, así como en el estriado izquierdo y la amígdala derecha. Esto sugiere una reducción en la dopamina endógena en regiones mesolímbicas en pacientes con Parkinson apáticos, un hallazgo confirmado por la administración aguda de metilfenidato. De hecho, después de la administración de esta sustancia, que aumenta la liberación de dopamina en las terminales dopaminérgicas, el desplazamiento de [11C]racloprida fue significativamente menos pronunciado en estas regiones en pacientes apáticos que en pacientes no apáticos, lo que sugiere una menor reserva de dopamina en individuos apáticos. Esta disminución de dopamina, preexistente antes de la intervención, se revelaría por la reducción de los tratamientos dopaminérgicos tras la intervención. También parece mejorar tras el tratamiento con un agonista dopaminérgico (Czernecki et al., 2008). Aunque estos resultados abogan por un origen hipodopaminérgico de la apatía del paciente parkinsoniano, es probable que intervengan otros neuromoduladores, en particular la serotonina (Rodríguez-Oroz et al., 2009) o la acetilcolina, como sugieren los importantes vínculos entre la apatía y el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson (Dujardin et al., 2009; Pedersen et al., 2009b) , así como los vínculos entre la aparición de apatía y el empeoramiento de los signos axiales de la enfermedad (Pedersen et al., 2009a).

Parece haber varios tipos de apatía en la enfermedad de Parkinson. En algunos casos, se manifiesta como una incapacidad para decodificar la valencia emocional y afectiva de los estímulos responsables de su valor motivacional, lo que lleva a una menor voluntad para realizar actividades y/o mantenerlas para lograr un objetivo. Esto sería el resultado de una disfunción de las regiones ventrales del cuerpo estriado, probablemente de origen dopaminérgico. La apatía también puede reflejar, a través de la inercia cognitiva, una incapacidad para planificar y llevar a cabo conductas dirigidas a objetivos, vinculada al declive de las funciones cognitivas. Sería entonces el resultado de una disfunción del circuito asociativo que conecta las regiones asociativas del cuerpo estriado con la corteza prefrontal lateral y otras regiones corticales asociativas, probablemente involucrando la dopamina pero también otros neuromoduladores.

4. Evaluación de la apatía

Dado el impacto de la apatía en el funcionamiento y la calidad de vida de los pacientes, es fundamental poder detectarla y evaluar su gravedad mediante instrumentos válidos. Existen diversas escalas, cuyas propiedades psicométricas han sido revisadas por un grupo de trabajo de la Sociedad de Trastornos del Movimiento (Leentjens et al., 2008). Marin et al. (1991) fueron los primeros en proponer una escala: la Escala de Evaluación de la Apatía.

Machine Translated by Google

(AES), específicamente dedicada a la medición del síndrome de apatía. Su validez y sensibilidad para evaluar la apatía en diferentes patologías están claramente establecidas, lo que probablemente explica por qué es la más utilizada. Sin embargo, su validez no se ha demostrado en la enfermedad de Parkinson.

Esta escala está disponible en varias versiones, basadas ya sea en el discurso espontáneo del paciente, ya en la opinión del informante más cercano o administrables mediante autoevaluación.

Sin embargo, la Escala de Apatía (EAE) adolece de falta de estandarización en las instrucciones de administración y los métodos de puntuación. Starkstein et al. (1992) propusieron una versión abreviada, la Escala de Apatía (EA). Los 14 ítems se administran mediante preguntas leídas en voz alta al paciente (p. ej., "¿Se siente motivado?") y el paciente debe elegir su respuesta entre cuatro posibilidades (nada, poco, bastante, mucho). También existe una versión para cuidadores. Lamentablemente, la EA solo se ha validado con una muestra bastante pequeña de pacientes con Parkinson. Numerosos estudios clínicos y farmacológicos utilizan el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI, Cummings et al., 1994) para evaluar los trastornos neuropsiquiátricos en enfermedades neurológicas. Este permite evaluar la presencia y la gravedad de 12 síntomas, incluida la apatía, mediante una entrevista semiestructurada con el cuidador. Se ha demostrado la validez y la fiabilidad de cada subescala. Por lo tanto, el NPI permite la evaluación por separado de la apatía, la depresión y otros trastornos del comportamiento. Una puntuación de 4 o superior indica la presencia de un trastorno clínicamente significativo (Aalten et al., 2005). El principal obstáculo es que el uso del NPI depende completamente de la disponibilidad de un cuidador confiable. Una versión revisada que incluye un método...

Administración de inventarios en ausencia de un cuidador

Se publicó recientemente y muestra cualidades psicométricas bastante buenas (de Medeiros et al., 2010). Aún no se ha probado en la enfermedad de Parkinson.

Basándose en los principios del NPI, Robert et al. (2002) validaron el Inventario de Apatía (IA), que permite tanto una calificación global de la apatía como una calificación en tres dominios (embotamiento afectivo, falta de iniciativa y pérdida de interés). Además de la versión basada en una entrevista con el cuidador, el IA ofrece una versión en forma de cuestionario autoadministrado, que permite comparar las opiniones del paciente y sus familiares. Se han establecido las propiedades psicométricas de esta escala, y el estudio de validez externa mostró que la puntuación global de la versión del cuidador estaba fuertemente correlacionada con la puntuación en la subescala de apatía del NPI. Por el contrario, no hubo asociación entre los resultados del autocuestionario y la puntuación en la subescala de apatía del NPI, excepto en pacientes sin demencia, lo que sugiere que la administración del autocuestionario debería limitarse a este tipo de pacientes.

La Escala de Evaluación de Apatía de Lille (LARS, Sockeel et al., 2006) se desarrolló a partir del concepto de apatía definido por Marin (1991) para proporcionar un procedimiento estandarizado de evaluación de la apatía. La escala se presenta como una entrevista estructurada para el paciente. Consta de 33 ítems divididos en nueve dominios que corresponden a las diferentes manifestaciones clínicas de la apatía, cada uno de los cuales contribuye por igual al cálculo de la puntuación total. La escala, que presenta propiedades psicométricas satisfactorias, ha sido validada.

Se realizó un estudio con una muestra de 159 pacientes con Parkinson y 58 sujetos sanos. Los resultados revelaron una estructura cuatridimensional (curiosidad intelectual, iniciación de la acción, emoción y autocrítica) que permitió definir perfiles de apatía. Un estudio de sensibilidad y especificidad permitió definir una puntuación umbral para el diagnóstico de apatía y proponer niveles de gravedad. También se validó una versión diseñada para cuidadores (Dujardin et al., 2008).

L'item 4 « Motivation/Initiative » de l'Unified Parkinson's

La Escala de Calificación de la Enfermedad (UPDRS-I) se utiliza con frecuencia para detectar y evaluar la apatía en la enfermedad de Parkinson (Pedersen et al., 2008). Sin embargo, se trata de un instrumento extremadamente rudimentario que ignora el componente emocional de la apatía. Sus cualidades psicométricas son cuestionables (Leentjens et al., 2008) , por lo que su uso requiere cierta precaución (Kirsch-Darrow et al., 2009).

Estas escalas varían en longitud, contenido y formato de los ítems. Un análisis realizado por el grupo de trabajo de la Sociedad de Trastornos del Movimiento compara sus ventajas y desventajas (Leentjens et al., 2008) y da lugar a recomendaciones sobre el uso de estas diferentes escalas en la enfermedad de Parkinson.

Sin embargo, su uso como herramienta diagnóstica se ve limitado por la falta de validación con respecto a los criterios de referencia, ya que todos se desarrollaron antes de su publicación (Robert et al., 2009). Por lo tanto, es deseable evaluar su sensibilidad y especificidad con respecto a estos criterios.

5. Conclusión

La apatía es uno de los principales trastornos del comportamiento observados en la enfermedad de Parkinson. Aunque es más frecuente en pacientes avanzados o en casos de demencia, afecta a todas las etapas de la enfermedad. Reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes y es la manifestación que mayor impacto tiene en la carga de los cuidadores (Leiknes et al., 2010). Estudios recientes han permitido avanzar en el reconocimiento de este trastorno, en particular gracias al consenso en torno a los criterios diagnósticos y al desarrollo de herramientas de evaluación específicas. El conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a este trastorno también ha avanzado significativamente. Se necesita más investigación para desarrollar tratamientos terapéuticos.

Declaración de intereses

Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este artículo.

re´ fe´ rences

Aalten P, van Valen E, Clare L, Kenny G, Verhey F. Conciencia en la demencia: una revisión de correlatos clínicos. Envejecimiento Ment Health 2005;9(5):414–22.

Machine Translated by Google

Aarsland D, Marsh L, Schrag A. Síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Parkinson. Mov Disord 2009;24(15): 2175–86.

Cummings JL. Circuitos fronto-subcorticales y comportamiento humano. Arch Neurol 1993;50(8):873–80.

Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. El Inventario Neuropsiquiátrico: evaluación integral de la psicopatología en la demencia. Neurología 1994;44(12):2308–14.

Czernecki V, Pillon B, Houeto JL, Pochon JB, Levy R, Dubois B. Motivación, recompensa y enfermedad de Parkinson: influencia de la dopaterapia. Neuropsychologia 2002;40(13):2257–67.

Czernecki V, Schupbach M, Yaici S, Levy R, Bardinet E, Yelnik J, et al. Apatía tras estimulación subtalámica en la enfermedad de Parkinson: un síntoma de respuesta dopaminérgica. Mov Disord 2008;23(7):964–9.

de Medeiros K, Robert P, Gauthier S, Stella F, Politis A, Leoutsakos J, et al. Inventario Neuropsiquiátrico-Escala de Calificación Clínica (NPI-C): Fiabilidad y validez de una evaluación revisada de los síntomas neuropsiquiátricos en la demencia. Int Psychogeriatr 2010;22(6):984–94.

Drijgers RL, Dujardin K, Reijnders JS, Defebvre L, Leentjens AF. Validación de criterios diagnósticos para la apatía en la enfermedad de Parkinson. Parkinsonism Relat Disord 2010;16(10):656–60.

Dujardin K, Sockeel P, Delliaux M, Destee A, Defebvre L. Escala de Apatía de Lille: validación de una versión para cuidadores. Mov Disord 2008;23(6):845–9.

Dujardin K, Sockeel P, Delliaux M, Destee A, Defebvre L. La apatía puede anunciar deterioro cognitivo y demencia en la enfermedad de Parkinson. Mov Disord 2009;24(16):2391–7.

Dujardin K, Sockeel P, Devos D, Delliaux M, Krystkowiak P, Destee A, et al. Características de la apatía en la enfermedad de Parkinson. Mov Disord 2007;22(6):778–84.

Kirsch-Darrow L, Fernández HH, Marsiske M, Okun MS, Bowers D. Disociando la apatía y la depresión en la enfermedad de Parkinson. Neurología 2006;67(1):33–8.

Kirsch-Darrow L, Zahodne LB, Hass C, Mikos A, Okun MS, Fernandez HH, et al. ¿Cuán cautelosos debemos ser al evaluar la apatía con la Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson? Mov Disord 2009;24(5):684–8.

Le Jeune F, Drapier D, Bourguignon A, Peron J, Mesbah H, Drapier S, et al. La estimulación del núcleo subtalámico en la enfermedad de Parkinson induce apatía: un estudio PET. Neurología 2009;73(21):1746–51.

Leentjens AF, Dujardin K, Marsh L, Martinez-Martin P, Richard IH, Starkstein SE, et al. Escalas de evaluación de la apatía y la anhedonia en la enfermedad de Parkinson: crítica y recomendaciones. Mov Disord 2008;23(14):2004–14.

Leiknes I, Tysnes OB, Aarsland D, Larsen JP. Distrés del cuidador asociado con problemas neuropsiquiátricos en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana: el estudio noruego ParkWest. Acta Neurol Scand 2010;122(6):418–24.

Levy ML, Cummings JL, Fairbanks LA, Masterman D, Miller BL, Craig AH, et al. La apatía no es depresión. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1998;10(3):314–9.

Levy R, Dubois B. Apatía y anatomía funcional de los circuitos corteza prefrontal-ganglios basales. Cereb Cortex 2006;16(7):916–28.

Marin RS. Apatía: un síndrome neuropsiquiátrico. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1991;3(3):243–54.

Marin RS, Biedrzycki RC, Firinciogullari S. Fiabilidad y validez de la Escala de Evaluación de Apatía. Psychiatry Res 1991;38(2):143–62.

Marsh L, McDonald WM, Cummings J, Ravina B. Criterios diagnósticos provisionales para la depresión en la enfermedad de Parkinson: informe de un grupo de trabajo del NINDS/NIMH. Mov Disord 2006;21(2):148–58.

Migneco O, Benoit M, Koulibaly PM, Dygai I, Bertogliati C, Desvignes P, et al. El análisis de SPECT cerebral de perfusión y el mapeo paramétrico estadístico indican que la apatía es un síndrome cingulado: un estudio en pacientes con enfermedad de Alzheimer y sin demencia. Neuroimagen 2001;13(5):896–902.

Mulin E, Leone E, Dujardin K, Delliaux M, Leentjens A, Nobili F, et al. Criterios diagnósticos de apatía en la práctica clínica. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26(2):158–65.

Pedersen KF, Larsen JP, Aarsland D. Validación de la Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson (UPDRS), sección I, como instrumento de cribado y diagnóstico de la apatía en pacientes con enfermedad de Parkinson. Trastorno relacionado con el parkinsonismo. 2008;14(3):183–6.

Pedersen KF, Alves G, Aarsland D, Larsen JP. Incidencia y factores de riesgo de apatía en la enfermedad de Parkinson: un estudio longitudinal prospectivo de 4 años. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009a;80(11):1279–82.

Pedersen KF, Larsen JP, Alves G, Aarsland D. Prevalencia y correlatos clínicos de la apatía en la enfermedad de Parkinson: un estudio comunitario. Parkinsonism Relat Disord 2009b;15(4):295–9.

Pedersen KF, Alves G, Bronnick K, Aarsland D, Tysnes OB, Larsen JP. Apatía en pacientes sin tratamiento previo con enfermedad de Parkinson incidente: el estudio noruego ParkWest. J Neurol 2010;257(2):217–23.

Pessiglione M, Schmidt L, Draganski B, Kalisch R, Lau H, Dolan RJ, et al. Cómo el cerebro traduce el dinero en fuerza: un estudio de neuroimagen de la motivación subliminal. Ciencia 2007;316(5826):904–6.

Pluck GC, Brown RG. Apatía en la enfermedad de Parkinson. J Neurol Neurocirugía Psiquiátrica 2002;73(6):636–42.

Reijnders JS, Ehrt U, Weber WE, Aarsland D, Leentjens AF. Una revisión sistemática de los estudios de prevalencia de la depresión en la enfermedad de Parkinson. Mov Disord 2008;23(2):183–9.

Reijnders JS, Scholtissen B, Weber WE, Aalten P, Verhey FR, Leentjens AF. Correlatos neuroanatómicos de la apatía en la enfermedad de Parkinson: un estudio de imágenes por resonancia magnética utilizando morfometría basada en vóxeles. Mov Disord 2010;25(14):2318–25.

Remy P, Doder M, Lees A, Turjanski N, Brooks D. Depresión en la enfermedad de Parkinson: pérdida de la inervación dopaminérgica y noradrenalina en el sistema límbico. Brain 2005;128(Pt 6):1314L 1322.

Robert P, Onyike CU, Leentjens AF, Dujardin K, Aalten P, Starkstein S, et al. Criterios diagnósticos propuestos para la apatía en la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neuropsiquiátricos. Psiquiatría Europea 2009;24(2):98–104.

Robert PH, Berr C, Volteau M, Bertogliati C, Benoit M, Sarazin M, et al. Apatía en pacientes con deterioro cognitivo leve y riesgo de desarrollar demencia por enfermedad de Alzheimer: un estudio de seguimiento de un año. Clin Neurol Neurosurg 2006;108(8):733–6.

Robert PH, Clairet S, Benoit M, Koutaich J, Bertogliati C, Tible O, et al. El inventario de apatía: evaluación de la apatía y la consciencia en la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el deterioro cognitivo leve. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17(12):1099–105.

Rodríguez-Oroz MC, Jahanshahi M, Krack P, Litvan I, Macias R, Bezard E, et al. Manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad de Parkinson: características y mecanismos fisiopatológicos. Revista de Neurología 2009;8(12):1128–39.

Sarazin M, Michon A, Pillon B, Samson Y, Canuto A, Gold G, et al. Correlatos metabólicos de comportamiento y afectivo. Trastornos en patologías del lóbulo frontal. J Neurol 2003;250(7):827–33.

Sockeel P, Dujardin K, Devos D, Deneve C, Destee A, Defebvre L. Escala de Lille para la Apatía (LARS), un nuevo instrumento para detectar y cuantificar la apatía: validación en la enfermedad de Parkinson. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77(5):579–84.

Machine Translated by Google

Starkstein SE, Mayberg HS, Preziosi TJ, Andrezejewski P, Leiguarda R, Robinson RG. Fiabilidad, validez y correlatos clínicos de la apatía en la enfermedad de Parkinson. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1992;4(2): 134–9.

Stuss DT, van Reekum R, Murphy KJ. Diferenciación de estados y causas de la apatía. En: Borod J, editor. Neuropsicología de la emoción. Nueva York: Oxford University Press; 2000. pp. 340–63.

Thobois S, Ardouin C, Lhommee E, Klinger H, Lagrange C, Xie J, et al. Síndrome de abstinencia dopaminérgica no motora tras cirugía para la enfermedad de Parkinson: predictores y denervación mesolímbica subyacente. Brain 2010;133 (Pt 4):1111L 1127.

Voon V, Kubu C, Krack P, Houeto JL, Troster AI. Estimulación cerebral profunda: aspectos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos. Mov Disord 2006;21 (Supl. 14):S305–27.